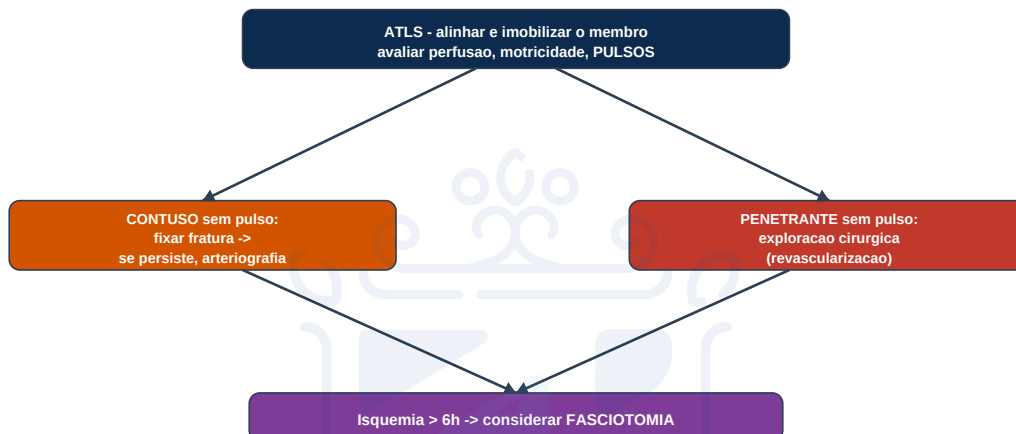


TRAUMA VASCULAR DE EXTREMIDADES

FLUXOGRAMA — PULSO E TRAJETO

TRAUMA VASCULAR — ABCDE, ALINHAR, AVALIAR PULSO



CONCEITOS BÁSICOS

O QUE É

- Modalidade: PENETRANTE (facada, arma de fogo, empalamento) x CONTUSO (fraturas, esmagamento, estiramento)
- Pode ou não estar associado a fraturas ósseas
- Pacientes em geral JOVENS, sem circulação colateral (toleram mal a isquemia)
- 1o passo SEMPRE: atendimento ao traumatizado pelo ATLS

AValiação E CONFUNDIDORES

APÓS ALINHAR E IMOBILIZAR

- Após o ATLS, o membro deve estar ALINHADO e IMOBILIZADO
- Avaliação completa de PERFUSÃO e MOTRICIDADE + palpação de pulsos (comparar com o contralateral)
- Confundidores do exame: déficit neurológico secundário a fratura, à isquemia ou à lesão de nervo
- Ausência de pulso pode ser por lesão vascular OU vasoespasmo
- O exame físico NÃO topografa a lesão exata no trauma contuso

CONDUTA — CONTUSO x PENETRANTE

Cenário	Conduta
Contuso SEM pulso	1a etapa: fixação da fratura (ortopedia). Se PERSISTE sem pulso -> ARTERIOGRAFIA diagnóstica (não dá para topografar pelo exame)
Contuso COM pulso	Avaliar perfusão/motricidade; atenção à luxação de joelho (alto risco de lesão de poplítea)
Penetrante SEM pulso	Exploração CIRÚRGICA de revascularização (controle vascular + exploração do local presumido)
Penetrante COM pulso	Se trajeto compatível com feixe vascular -> imagem não invasiva (lesão parcial). Se não compatível -> não prosseguir investigação

RED FLAGS — ISQUEMIA E LUXAÇÃO DE JOELHO

NÃO SUBESTIMAR

- Luxação/instabilidade de JOELHO: alto risco de lesão INTIMAL da artéria POPLÍTEA -> trombose e isquemia
- -> SEMPRE imagem (AngioTC/arteriografia) MESMO com todos os pulsos presentes na avaliação inicial
- Isquemia de membro > 6h -> considerar FASCIOTOMIA (prevenir síndrome compartimental)
- Penetrante sem pulso = exploração cirúrgica (não atrasar com exames)
- Sinais 'duros' de lesão vascular (sangramento pulsátil, hematoma expansivo, isquemia franca) -> cirurgia

ENXERTO NO TRAUMA VASCULAR

Rx

PRINCÍPIOS DA REVASCULARIZAÇÃO

Sempre PRESUMIR lesão concomitante do sistema venoso profundo
Enxerto com veia SAFENA CONTRALATERAL (evita insuficiência venosa/congestão no membro traumatizado)
Veia INVERTIDA (válvulas); preferir o MENOR enxerto possível
Anastomose término-terminal com diâmetros semelhantes (economiza tempo)
Atenção a lesão de nervo concomitante; reavaliar perfusão após revascularizar

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ ATLS; controlar hemorragia externa (compressão; torniquete se exsanguinante)
- ☐ Alinhar e imobilizar o membro; avaliar perfusão, motricidade e pulsos comparados
- ☐ Contuso sem pulso: fixar fratura e reavaliar; se persiste -> arteriografia
- ☐ Penetrante sem pulso: cirurgia; luxação de joelho: imagem mesmo com pulso
- ☐ Isquemia > 6h -> fasciotomia; acionar cirurgia vascular e transferir se necessário

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma vascular de extremidade ____ (contuso/penetrante), membro ____; fratura associada: ____.
- Pulsos distais: presentes/ausentes; perfusão/motricidade: ____; tempo de isquemia: ____ h.
- Conduta: fixação + arteriografia / exploração cirúrgica / fasciotomia.
- Solicito cirurgia vascular + hemodinâmica/centro cirúrgico (tempo de isquemia é crítico).

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Trauma penetrante (arma de fogo) em coxa, ausência de pulso pedioso e tibial posterior. Conduta?

- A) Apenas observação e elevação do membro
- B) Exploração cirúrgica de revascularização (controle vascular e exploração do trajeto)
- C) Arteriografia eletiva ambulatorial
- D) Imobilização e alta
- E) Aguardar retorno espontâneo do pulso

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com luxação de joelho, mas com todos os pulsos distais presentes. Conduta correta?

- A) Alta, pois os pulsos estão presentes
- B) Realizar imagem vascular (AngioTC/arteriografia) pelo alto risco de lesão da artéria poplítea
- C) Apenas imobilizar
- D) Fasciotomia imediata
- E) Repetir exame em 30 dias

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

No trauma vascular CONTUSO sem pulso, qual é a primeira etapa antes da investigação vascular?

- A) Arteriografia imediata
- B) Fixação da fratura (ortopedia) e reavaliação do pulso
- C) Exploração cirúrgica imediata
- D) Fasciotomia
- E) Enxerto de safena

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

A partir de quanto tempo de isquemia de membro deve-se considerar fasciotomia para prevenir síndrome compartimental?

- A) 1 hora
- B) Mais de 6 horas
- C) 24 horas
- D) 48 horas
- E) Nunca é indicada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o enxerto na revascularização de trauma vascular de extremidade, é correto:

- A) Usar a veia safena ipsilateral ao trauma
- B) Usar veia safena CONTRALATERAL invertida (evita insuficiência venosa no membro traumatizado)
- C) Sempre material protético
- D) Anastomose látero-lateral ampla
- E) Nunca presumir lesão venosa associada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Trauma penetrante sem pulso = lesão vascular presumida com trajeto topografável -> exploração cirúrgica de revascularização, sem atrasar com exames. O trauma penetrante permite presumir a localização da lesão.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A luxação de joelho tem alto risco de lesão intimal da artéria poplítea (trombose/isquemia tardias); por isso indica-se imagem vascular MESMO com pulsos presentes na avaliação inicial.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No contuso sem pulso, a 1ª etapa é a fixação da fratura (o desalinhamento pode causar a ausência de pulso); se o pulso persistir ausente após a fixação, faz-se arteriografia (o exame não topografa a lesão).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Isquemia de membro > 6h aumenta muito o risco de síndrome compartimental de reperfusão; nesses casos considera-se fasciotomia para descomprimir e preservar o membro.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Prefere-se a veia safena CONTRALATERAL invertida: usar a safena ipsilateral pioraria a drenagem venosa do membro traumatizado (que frequentemente tem lesão venosa profunda associada), causando congestão.

SM24
Suporte ao Plantão Médico